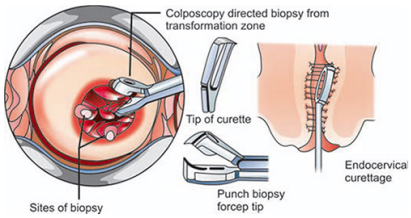
1'월경통／월경전증후군

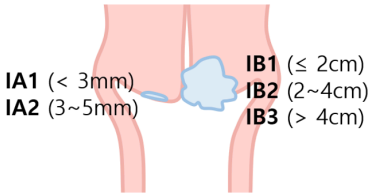
1. 1차성(기저질환이 없는) 월경통은 NSAID 주고, 불응시 피임약 주다.
2. 참고로 월경 2주전 통증은 월경통이 아니라 배란통이다.
3. 월경전증후군은 SSRI 준다.

자궁용종

1. 자궁에는 근종 말고 용종도 생기는데, 그냥 자궁경으로 자르면 된다.

경부암

1. 경부암 work up은 Pap smear → 질확대경 조직검사/경부긁어냄술 → 수술 로 이루어진다.
2. Pap smear 결과, 정상이거나 HPV(-)인 의미미결정/저등급 인 경우에만 Pap smear 추적을 하고, 나머지는 전부 질확대경으로 보면서 조직검사(경부표면)와 경부긁어냄술(경관안쪽)을 시행해야 한다. (단 임신부인 경우, 경부긁어냄술은 위험해서 질확대경 조직검사만 시행한다.)
   - 

3. 질확대경 조직검사/경부긁어냄술에서 나온 병리 결과에 따라 술식을 결정한다.
   - CIN1 → 추적관찰
   - CIN2~3 → 원추절제술
   - 상피내암종(CIS)~상피세포암(Invasive Carcinoma) 침윤≤3mm → 전자궁절제
   - 

   - 상피세포암 침윤 >3mm → 근치적(광범위) 자궁절제
   - 상피세포암 자궁주위조직 침범 → CCRT (수술X)[1]

1. 난소암의 복막전이와 헷갈리면 안된다. 복막전이어도 수술하는 암은 난소암이 유일

난소꼬임 vs 자궁외임신

1. 난소꼬임과 자궁외임신 모두 한쪽 아랫배 급성복통으로 올 수 있다.
2. 난소꼬임은 기형종이 흔한 원인이며, 꼬일때마다 심해지는 Wax&Wane 통증이 특징이며, 꼬임풀기+낭종절제술을 해야한다.
3. 마지막월경시작일이 6주전이지만, 자궁내에 임신낭이 보이지 않을 때 2가지 가능성이 있다.
   - hCG가 낮은 경우 → 임신낭은 원래 6주부터 슬슬 보이니까 조금 있으면 보이겠구나
   - hCG가 높은 경우(≥몇천) → 자궁외에 임신낭이 있을 것이다!
4. 자궁외 임신낭을 초음파로 확인했을 경우, 다량출혈 소견 있으면 난관절제술을 해버리고, 괜찮은 상태면 MTX로 중절한다.

1' 무월경

1. 일차성 무월경 정의: 이차성징 없는 여학생이 13세돼도 초경없거나, 이차성징 있는 여학생이 15세돼도 초경이 없음.
   - 이차성징있는 14세는 정상임
2. 난포자극/황체형성 호르몬이 감소되는 무월경은 체질적지연과 칼만증후군이 있다.
   - 조기난소부전은 오히려 난포자극/황체형성 호르몬이 증가하며, E+P 줘야한다.
3. 그렇지 않은 무월경은 처녀막막힘/조기난소부전을 제외하면, 전부 염색체 문제로, 염색체검사를 먼저 해야 한다.
4. 터너증후군은 45,X이고, 에스트로겐 주면 되는데, 45,X/46,XY이라면 고환제거술도 같이 해야한다. 신장비뇨기형/대동맥축착이 동반된다.
5. 뮐러관무발생은 46,XX이지만 자궁이 없어서 맹관이다. 신장비뇨기형/척추기형이 동반된다.
6. 안드로겐무감응도 자궁이 없어서 맹관이지만, 애초에 46,XY이다. 음모가 없는게 특징인데, 고환제거하고 에스트로겐 줘서 여자로 살게 한다.
7. 반면, 46,XY이지만 자궁과 음모가 있는 스와이어 증후군이라는 것도 있다.

2' 무월경

1. 2차성 무월경 정의: 초경했던 여자가 나중에 3개월 이상 월경이 없는 것.
2. 난포자극/황체형성 호르몬이 감소되는 무월경은 쉬한증후군/고프로락틴혈증이 있다.
3. 일단 당연히 hCG(사람융모생식샘자극호르몬)이 음성임을 먼저 확인한다.
4. 최근 중절/긁어냄술(+)이라면 자궁조영술/자궁경으로 유착을 확인하고, 유착절제술해주면 된다.
5. 최근 중절/긁어냄술(-)이라면 호르몬검사(난/황/갑/프)가 제일 중요하다. 극소수의 초경이 가능한 터너를 배제하기 위해 염색체검사를 하기도 한다.
6. 호르몬검사에서 ↑난/황(±)이면 조기폐경으로, E+P로 치료한다.
7. 여드름/다모증/다낭성난소(+)이면 당연히 PMOS이고, 무월경에 대해서 E+P(35세흡연/유방암/심뇌혈관질환 있다면 P만)로 치료하고, 임신에 대해서 레트로졸(방향화효소억제제)와 클로미펜(선택적 에스트로겐 수용체 조절제)로 치료한다.

비정상 자궁출혈

1. 임신을 배제후, 초음파를 찍던지, 일단 피임약 주고 돌려보낸다.
2. 출혈이 너무 지속적이면 응고검사를 생각한다.
3. 내막두께>14mm(+) 일때, >35세(+) 이면 내막증식증을 의심하고 생검하지만, <35세(+)이고 평소에도 월경이 불규칙했다면 무배란 질출혈을 의심하고 P만 줘도 된다.
4. 내막두께<2mm(+) 이면 반대로 E를 줘야 한다.

월경 생리학

1. GnRH(생식샘자극호르몬방출호르몬)의 자극에 따라, 뇌하수체에서 생식샘자극호르몬(난포자극호르몬/황체형성호르몬)이 분비된다.
2. 난/황 호르몬은 E를 생성하며, 황 호르몬은 말 그대로 황체를 형성하여, P를 생성한다.
3. 1일~14일은 난포기, 15일~28일은 황체기이다. 14일에 LH surge를 통해 난포에서 난자가 배란되고, 그 껍데기는 황체로 남는다.
4. 에스트로겐은 내막을 증식시킨다.
5. 프로게스테론은 양날의 검이다. 작용하는 동안엔 내막증식을 억제하고 안정화(유지)시키지만, 프로게스테론이 낮아지면 바로 내막 탈락이 시작된다.

폐경

1. 폐경의 진단은 난포자극호르몬>40(+)으로 한다.
2. 자궁이 있는 경우, 그냥 E+P주면 되는데, E금기(유방암/심혈관/흡연)이면 SSRI/SNRI만 주고, LNG-IUD 이미 있으면 E만 주면 된다.
3. 자궁이 없는 경우, E만 주면 되는데, 오직 내막증만 P까지 줘야한다.
4. 위에서 말한건 모두 경구 얘기이다. 성교통에서의 에스트로겐 질정은 E금기와 전혀 상관없어서 무지성으로 줘도 된다.
5. 폐경기 골다공증에서는 비스포스포네이트 or 데노수맙을 단독으로 쓴다. E와 같이주면 안된다고 한다. Cr>1.5(+)에서는 데노수맙을 선호하며, 별개로 유방암(+)이면 아예 랄록시펜을 써야한다.

바르톨린 vs 자궁탈출 vs 콘딜로마

1. 외음부에 궤양이 있다면 단순포진/chancroid/매독을 의심하면 되지만, 외음부에 덩이가 있다면 바르톨린/자궁탈출/콘딜로마를 생각해야 한다.
2. 바르톨린샘종은 무증상 경과관찰하며, 통증이 있으면 배농하고 항생제 주면 된다.
3. 자궁탈출은 빈뇨/절박뇨 동반할 수 있으며, 자궁적출하는게 가장 좋지만, 임시방편으로 페서리를 잠깐 넣어볼 수도 있다.
4. 콘딜로마는 HPV때문에 생기며 냉동치료/염화아세트산/포도필린/이미퀴모드 로 제거하는데, 포도필린/이미퀴모드는 임신부 금기이다.

경부염~질염~외음부궤양

1. 질염/경부염/골반염 모두 냄새나는 질분비물을 주소로 내원한다. 감별점은 질염은 가려움(+), 경부염은 자궁목분비물(+), 골반염은 복통(+) 4대염증수치(+) 이다.
2. 질염의 종류와 항생제는 다음과 같은데, 이중 칸디다/가드넬라는 상재균이어서 무증상이면 치료 안 한다. 현미경 사진도 외워야 한다.
   - 트리코모나스 편모충 → 메트로
   - 칸디다 → 플루코나졸/클로트리마졸
   - 가드넬라(세균성 질염) → 메트로/클린다
3. 외음부궤양의 종류와 항생제는 다음과 같다.
   - 단순포진 → 아시클로버
   - chancroid(연성하감) d/t H. ducreyi → Azi
   - 매독(경성하감) → 페니실린
4. 태선도 가려움증을 주소로 오는데, 펀치생검한다.

골반염

1. 자궁내막/난관/난소/골반복막의 염증을 골반염이라고 부르며, 질염/경부염은 포함되지 않는다.
2. 골반염은 노란색 분비물 뿐만 아니라 복통(+) 4대염증수치(+)가 심하다.
3. 어차피 클라미디아/임균 이므로 독시트리악손 쓰면 된다.
4. 골반염에 난소농양까지 있으면 배농/수술까지 고려해야한다. 특히 반동압통 있으면 응급수술.
5. 특히 클라미디아 골반염의 합병증으로 peri.hepatitis가 있다. CT에서 간표면이 밝거나, 복강경 violin string sign이 주어지면 Azi/독시 쓸 생각 해야한다.
6. 이 외에, IUD 사용으로 생기는 방선균에는 페니실린을 쓴다.
7. 이 외에, 분만후 골반염으로 인한 분비물을 오로라고 하며, 항생제 쓰면 되지만, 자궁곁광범위연조직염으로 퍼지면 반동압통까지 생기고 수술해야 한다.

불임

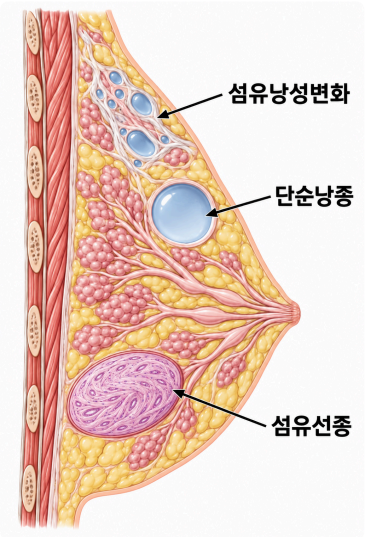
1. 1년 이상 임신이 안돼야 불임으로 진단한다.
2. 자궁난관조영술에서 난관폐쇄/난관수종 소견이 보이면, 난자가 난소로 이동하지 못하는 상태이므로, 난자를 빼내서 시험관에서 체외수정 시킨다.
3. 반면, 정자 운동성 쪽에 문제가 있는 경우, 세포질내 정자주입술을 시행한다.
4. 임신만 안되는게 아니라, 월경도 없을 경우, 난포자극호르몬/항뮬러관호르몬 검사를 통해 난소예비력 자체를 확인해야 한다. 임신(-) 월경(-)은 3가지 케이스가 있다.
   - 터너증후군 → 아예 고자이기 때문에 난자공여를 받아야한다.
   - 조기폐경 → 생식샘자극호르몬(난/황)이나 사람폐경.생식샘자극호르몬을 줘서 배란유도.
   - 자궁내막유착 → 조영술/자궁경으로 검사하고 유착절제술하면 치료된다.
5. 항암치료를 해도 고자가 된다, 그래서 가임력 보존을 위해 배아동결을 하면 되는데, 낚시선지로 난자동결 등이 나온다.
6. 불임에서 해야하는 여러 검사들 중, 월경주기를 신경써야 하는 것들이 많다. 월경시작 3일째에 난포자극호르몬 검사, 6일째에 자궁난관조영술 한다는 거는 자주 나와서 외워두자.
7. 체외수정할때 난포생성위해 FSH 주는데, 난포가 과생성되면 혈관투과성이 증가해 수분이 복수로 빠져나가고 혈액이 농축된다. 따라서, 체외수정 환자가 배가 불러서 왔다면 수액/헤파린을 줘야한다.

요실금

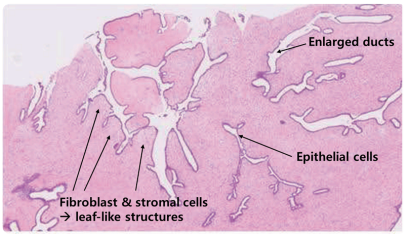
1. 절박요실금은 방광훈련/항콜린제 치료하면 되는데, 절박뇨를 동반할 수 있는 다른 질환(UTI/자궁탈출)을 배제해야 한다는 것만 조심하면 된다.
2. 복압요실금은 골반저근육운동 → 둘록세틴 → 요도슬링(무긴장성테이프) 로 단계적 치료한다.

유방 양성종양

1. 산후/수유중에는 유방울혈/유방염/유방농양 나타날 수 있고, 유방울혈은 발적(-)이고 경과관찰해도 된다.
2. 산후/수유중이 아니어도 발적(+)인 유륜/유관/유방 주위염증 생길 수 있는데, 덩어리가 있다면 염증성 유방암과 구분할 수 없어진다.
3. 단순낭종/섬유낭성 변화는 월경전에 커지거나 아파오는 덩이를 주소로 내원하며, 섬유선종은 이름은 비슷해보이지만, 고무같이 단단하며, 저에코 매끄러운 타원형을 보인다.

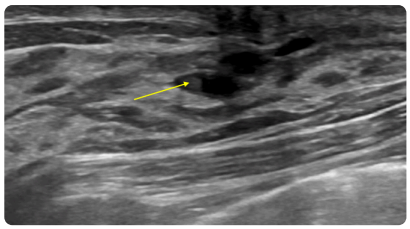


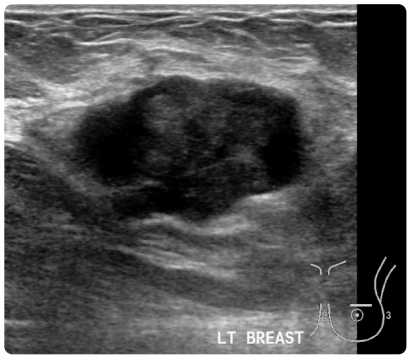
4. 엽상종양은 나뭇잎같은 병리소견을 보이며, 국소절제술 해야한다.

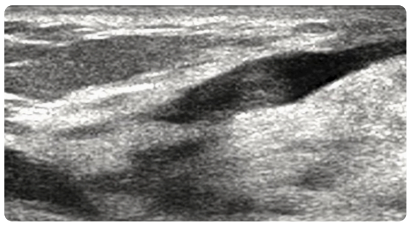


유방 양성종양 (계속)

5. 혈성분비물(+) 덩이(-) 는 관내유두종이고, 선택적 유관절제술 한다. 초음파 소견으로 구분할 줄 알아야 한다.







6. 지방괴사는 외상력만 뺀다면 암과 영상소견이 너무 동일하다. 무통성/단단한/경계불분명/고정/석회/별모양 모두 동일하다.

유방암_검사

1. 신체진찰에서, 무통/단단/고정/오렌지를 보고 의심한다.
2. 이미징은 크게 유방(확대)촬영과 초음파 2가지가 있다. 덩어리가 만져지거나, 20대/치밀유방이면 초음파가 유리하기 때문에 초음파하고, 그렇지 않다면 유방(확대)촬영을 한다. 이후 MRI를 추가 고려할 수 있다. 석회화/별모양/경계불분명이 의심소견이고, BIRADS 4부터 생검한다.
3. 촬영을 했으니 생검을 해야하는데, 바늘생검으로 확진되면 다행이지만, 불확실하게 나오면 수술실 가서 절제생검하는데, 이때 덩이가 만져지면, 만져가면서 덩이 떼내면 되지만, 안 만져지면 바늘위치결정술이라고 초음파보면서 일종의 부위표시를 해놓고 수술실 간다.
4. 병리 결과 나오면, 술전화학요법 치고, 수술하고, 수술할때 감시림프절도 몇개 떼서 검사한다.
5. 이후 HER2(+)면 트라스트주맙쓰면 된다. (HER2의 다른 이름이 C-erbB2라는것도 외우자)
6. 반면 ER(+) or PR(+)이면 타목시펜(에스트로겐 조절제)이나 레트로졸(방향화억제제) 쓰면 되는데, 폐경후에는 레트로졸을 더 선호한다.

유방암_술후합병증

1. winged scapula는 긴가슴신경
2. 팔감각저하는 갈비사이.위팔신경

유방암_종류

1. 유방암은 소엽(Lobular)과 관(Ductal) 두 곳에 생길 수 있는데, 관(Ductal)이 훨씬 예후가 안좋다. 단계는 크게 3가지인데, 비정형증식증(Atypical Hyperplasia) → 상피내암(Carcinoma In Situ) → 침윤성 암(Invasive Carcinoma)이다.
2. 침윤성 암(Invasive Carcinoma)은 수술은 당연하고, 방사선/화학/표적/호르몬 모든 치료를 사용하는 반면, 관상피내암(DCIS)는 수술후에 호르몬치료만 해도 된다. 소엽상피내암(LCIS)는 애초에 수술도 안 하고 경과관찰한다.
3. 염증성유방암은 침윤성관암(IDC)의 한 종류로, 발적(+) 압통(+)을 보인다.
   - 
4. 파젯병은 유두 표피에 암세포가 있는 질환으로, 유두 만성습진 소견을 보인다면 냅둘게 아니라 펀치생검을 해야한다.
   - 
   - 

자궁기형

1. 임신(착상)까지는 되는데 계속 유산한다면 자궁기형을 의심해야 한다. 중격절제술 하면 된다.

Endometriosis／oma

1. 내막증은 내막조직이 자궁이외 다른 곳에 존재하는 질환으로, 내막조직이니까 당연히 E 분비에 따라서 무럭무럭 자라는게 특징이다.
2. 3cm이상은 수술한다.
3. 수술 안할거면, E자극을 줄이기 위해 P를 주든지, 생자방 작용제를 줘야한다.[1]

1. 지속적인 생자방의 작용은 오히려 E 분비를 낮춘다.

근종 vs 선근증

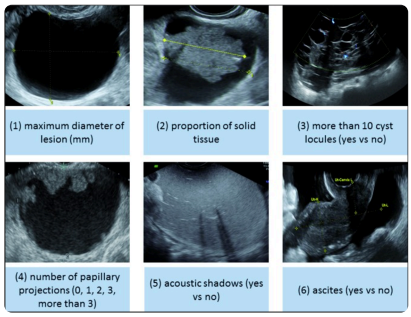
1. 근종하고 선근증 모두 무증상→월경통/과다→빈혈 을 보일 수 있다. 자궁이 전반적으로 커져있고 매끈/단단/둥글게 만져지면 선근증이다.
2. Hb<10(+)인 근종은 수술하는데, 자궁 안에 있으면 자궁경, 밖에있으면 복강경으로 떼내면 된다. 폐경(+)이면 그냥 자궁적출 하는게 제일 좋다.
3. 선근증은 수술이 아니라 P주면 된다. 물론 폐경(+)이면 그냥 자궁적출하는게 제일 좋다.

기형종

1. 우연히 발견될 수도 있고, 복통으로 올 수도 있다. 이빨때문에 고에코 acoustic shadow(+) 가 특징이다. 난소꼬임이 자주 동반돼서[1], 난소꼬임의 주증상인 급성 Wax&Wane 통증으로 올 수도 있다.
2. 3cm부터 수술한다.

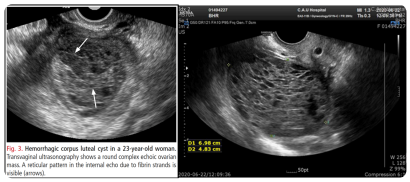
1. 기형종 구조상 무게중심이 치우쳐져있어서, 여자가 자세를 바꿀때 얘가 돌면서 난소를 꼬는 원리

난소암

1. CA-125(+)에 초음파상 다방성/고형/유두/울퉁불퉁(+) 이면 시험적개복술(TH+BSO)해야한다. 안타깝지만 자궁/양쪽난소 다 떼야하는게 중요.
   - 

2. 난소암은 해부학적으로 크게 침범하지 않아도 복막전이가 가능하다. 그래서, 복막전이소견(복수)가 있어도 화학요법만 하는게 아니라, 시험적개복해서 종양을 쳐낼수 있을 때까지 쳐내는 세포감축수술이라는걸 한다.

낭종_단순 vs 출혈성

1. 난포낭종(Follicular cyst)는 난포기에 호발하며 simple cyst형태가 특징으로, 경과관찰~피임약 정도로 충분 하다.
2. 황체낭종(Corpus luteal cyst)는 황체기에 호발하며, 파열/출혈이 잘 된다. reticular하게 생긴게 특징으로, 출혈로 인한 소량의 액체저류는 경과관찰~피임약[1] 정도로 되지만, 다량의 액체저류/Hb<10/반동압통 있다면 복강경 넣어봐야 한다.
   - 
3. 난포막황체낭종(Theca-luteal cyst)는 임신중에 과다한 hCG가 난포를 강제로 황체로 변환시켜서 생기는 낭종이다. 어쨌든 임신중에 발생한다는 것만 알면 된다.

1. 부인과 종괴 중 유일하게 E+P 다 필요함, 큰 치료효과는 없고, 새로운 낭종이 또 생기지 않게 해보는 정도임.

내막증식증→내막암

1. 자궁근층(Myometrium)을 내막(Endometrium)이 덮고있는데, 내막은 초음파상에서 훨씬 밝게 보인다. 밝게보이는 내막이 두꺼워진 사진을 인식할줄 알면 좋다.
2. 50대 여성이 내막두께가 0.5cm 이상이면 내막증식증일지 내막암일지 보기위해 내막생검을 하면되는데, 내막생검을 긁어냄술/흡인술로 시행한다는 것 까지 시험에 나온다.
3. 내막이 두꺼워진거니까 치료는 당연히 P주면 된다. LNG-IUD로 주면 더 좋겠지.

포상기태

1. 핵없는 난자에 정자2개가 들어오면(또는 1개가 들어오고 2배복사되면) 46XX/46XY이지만 모계유전자는 하나도 없는 완전포상기태가 되고, 특유의 snowstorm appearance를 보인다.
2. 핵있는 난자에 정자2개가 들어오면 69XXY 같은 웃기는 핵형을 갖게 되는 부분포상기태가 되고, 얘는 snowstorm appearance 안 보인다.
3. 치료는 긁어냄술 하면되고, 폐경했으면 그냥 적출하면 된다.

피임／성폭행

1. n일전 성관계에서 사후피임은 다음과 같다.
   - 이미 임신했으면 쩔수다.
   - 3일전 → LNG
   - 5일전 → 프리스탈/프리스톤
   - 7일전 → 구리
2. 사전피임에서, 흡연/심혈관(+)이면 피임약금기(LNG-IUD는 가능), 골반염(+)이면 IUD금기, 월경과다(+)이면 프로게스테론 선호 이다. 모두 금기일 때 콘돔 고르면 된다.
3. 피임약 어제 먹는거 까먹었으면 오늘 두 알 먹으면 된다.
4. 피임약/IUD 사용중 임신했으면 피임약중단/IUD제거 후 임신 지속하면 된다.
5. 성폭행 성병은 임클트 에이비매 인데, 임클트는 음성이어도 아지트리악손+메트로니다졸 주고, 에이비매는 음성이면 치료 안한다.